

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5060007-58.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DA FONSECA E SILVA

RECORRIDO: SANDRA DE CASSIA GAMA DOS SANTOS

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CASSAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO, EM RAZÃO DE MÚLTIPLAS LESÕES CEREBRAIS SUGESTIVAS DE IMPLANTE SECUNDÁRIO POR METÁSTASE ACOMETE A PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO DA CASSAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do evento 3. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2024.

5060007-58.2024.4.02.5101

510014236152 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5060007-58.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DA FONSECA E SILVA

RECORRIDO: SANDRA DE CASSIA GAMA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência (agravo de instrumento) interposta pela União Federal a fim de suspender os efeitos da tutela antecipada, na forma da decisão recorrida, que determinou que os réus promovam, dentro de suas esferas de competências administrativas, **a transferência para uma das unidades hospitalares públicas com serviço de ONCOLOGIA**, conforme laudo firmado pela Dra. Tainá Assunção Amorim (CRM 0121121-8) no Evento 1 Laudo 3, confirmado pelo NAT, consoante o parecer juntado no Evento 6, preferencialmente para o INCA, com utilização de ambulância para a transferência, em sendo necessária, à vista do real estado de saúde do requerente, sem olvidar da necessidade de eficiência do tratamento e seus custos, sob responsabilidade penal, civil e administrativa dos responsáveis, na forma da lei.

Em suas razões recursais, a União alega ausência de requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Sustenta que não cabe ao Judiciário escolher quem será tratado em primeiro lugar. Requer o efeito suspensivo e o inteiro provimento do recurso para a cassação da antecipação dos efeitos da tutela, ou, em caso de manutenção da decisão, o direcionamento do cumprimento da ordem judicial ao Estado.

Pedido indeferido no evento 3.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, a preservação da saúde é dever genérico solidário de todas as entidades federativas (art. 23, II e 196, CF/88). No entanto, as atribuições públicas específicas no campo da saúde, são descentralizadas, sendo a responsabilidade limitada à própria esfera de atribuições

definidas em lei, conforme dispõem os art. 197 e 200 CF/88.

Nesse particular, descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços de saúde são diretrizes básicas e princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde – SUS, “sic”:

“Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo.”

Regulamentando essa disposição constitucional e com ênfase especial à descentralização dos serviços, preceito inserido no art. 198, I CF/88, foram editadas as Leis nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e 8.142/90 (financiamento do SUS), além de inúmeras outras normas infraconstitucionais.

Nesse particular, é clara a Lei 8.080/90 quando determina a descentralização de medidas com ênfase para os municípios, conforme:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

(...)

Nos casos específicos de doenças oncológicas, a Lei 13.896/2019 promoveu alteração na Lei 12.732/2012, dispondo que exames relacionados ao diagnóstico de neoplasia maligna devem ser realizados no prazo de 30 (trinta) dias, o que só reforça o reconhecimento da necessidade de rápido diagnóstico para imediato tratamento, dentro do prazo de 60 dias previsto no art. 2º da Lei 12.732/2012, *in verbis*:

Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.

§ 2º Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos.

§ 3º Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. (Incluído pela Lei nº 13.896, de 2019) (Vigência)

No caso em tela, analisando o acervo documental, tem-se que o mesmo faz prova de que a parte autora possui quadro de múltiplas lesões cerebrais sugestivas de implante secundário por metástase, além de implantes hepático, ósseo e em base de hemitórax esquerdo, consoante laudo firmado pela Dra. Tainá Assunção Amorim (CRM 0121121-8) no Evento 1 Laudo 3, sendo indicado o tratamento oncológico pleiteado.

LAUDO MÉDICO

NOME: LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DA FONSECA
PRONTUÁRIO: 582777

PACIENTE MASCULINO, 67 ANOS, PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, USUÁRIO DE CANNABIS POR 20 ANOS, DEU ENTRADA NO HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR NO DIA 20/04/2024 APÓS QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA SEGUIDO DE TCE. REALIZOU TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO QUE DEMONSTROU MÚLTIPLAS LESÕES SUGESTIVAS DE IMPLANTE SECUNDÁRIO POR METÁSTASE. ENCAMINHADO PARA ENFERMARIA DE CLÍNICA MÉDICA PARA INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA. APRESENTANDO MASSA IRREGULAR EM BASE DE HEMITÓRAX ESQUERDO, IMPLANTE HEPÁTICO E ÓSSEO (COLUNA TORÁCICA E LOMBAR). PACIENTE SEGUE, SEM FOCO PRIMÁRIO DEFINIDO, AGUARDANDO REALIZAÇÃO DE BRONCOSCOPIA COM BIÓPSIA EM UNIDADE HOSPITALAR DEVIDO A QUEDA DO ESTADO GERAL DO MESMO, NÃO SENDO POSSÍVEL REALIZAR O EXAME NO SUPER CENTRO CARIÓICA. NO MOMENTO ENCONTRA-SE LÚCIDO, ORIENTADO, VERBALIZANDO MAS SEM CONDIÇÕES DE ALTA HOSPITALAR, NECESSITANDO DE AUXÍLIO PARA SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS TAIS COMO BANHO, ALIMENTAÇÃO E MOBILIZAÇÃO.

O Parecer NAT, juntado no Evento 6, confirma a indicação do tratamento pleiteado para a patologia que acomete a parte Autora, vejamos:

Trata-se de Autor, 67 anos, internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, apresentando múltiplas lesões cerebrais sugestivas de implante secundário por metástase, além de implantes hepático, ósseo e em base de hemitórax esquerdo (Evento 1, LAUDO3, Página 1), solicitando o fornecimento de vaga em unidade oncológica e tratamento oncológico (Evento 1, INIC1, Páginas 2 e 3).

As principais metas do tratamento do câncer são: cura, prolongamento da vida útil e melhora da qualidade de vida. Existem três formas principais de tratamento do câncer: quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Elas podem ser usadas em conjunto, variando apenas quanto à suscetibilidade dos tumores a cada uma das modalidades terapêuticas e à melhor sequência de sua administração. Atualmente, poucas são as neoplasias malignas tratadas com apenas uma modalidade terapêutica. Os especialistas médicos, responsáveis pela indicação da cirurgia oncológica, da quimioterapia e da radioterapia são, respectivamente, o cirurgião oncológico, o oncologista clínico e o radioterapeuta 1.

Informa-se que tratamento oncológico está indicado ao manejo da condição clínica do Autor - múltiplas lesões cerebrais sugestivas de implante secundário por metástase, além de implantes hepático, ósseo e em base de hemitórax esquerdo (Evento 1, LAUDO3, Página 1). Além disso está coberto pelo SUS, conforme a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - SUS (SIGTAP), na qual constam: tratamento clínico de paciente oncológico, tratamento de paciente sob cuidados prolongados por enfermidades oncológicas, sob os seguintes códigos de procedimento: 03.04.10.002-1, 03.03.13.006-7, considerando o disposto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES).

Superada estas questões, verifico que, mediante análise meramente perfunctória, encontro na exposição da lide a presença dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada deferida pelo Juízo *a quo*.

O deferimento do efeito suspensivo tem por objetivo impedir a ocorrência de dano de difícil reparação até o pronunciamento definitivo do colegiado.

Nesse contexto, analisando o presente caso não vislumbro qualquer possibilidade de dano irreparável à recorrente, cujas razões recursais apenas atacam o provimento antecipatório sem demonstrar fatos hábeis que pudessem afastar a verossimilhança da pretensão autoral.

Constato, ao reverso, que o risco de dano irreparável corre em prejuízo da Recorrida, diagnosticada com câncer de bexiga / carcinoma urotelial de baixo grau, que necessita da avaliação em uro-oncologia com o respectivo tratamento oncológico e o procedimento de nefrostomia com ou sem drenagem, em caráter de urgência, sob risco de evolução do seu quadro clínico, não tendo o recorrente juntado prova hábil e suficiente a ilidir as conclusões do Juízo *a quo*.

Portanto, vislumbro preenchidos os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela previstos no artigo 300 do CPC e entendo que os argumentos da União não são suficientes a gerar a revisão de plano da referida decisão.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso, mantendo a decisão do evento 3. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em

julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.

5060007-58.2024.4.02.5101

510014235983 .V2